

אופן מתן I.V.Sildenafil בטיפול נמרץ ילדים

עמוד 1 מתוך 2

תאריך אפקטיבי: 12.05.2026

התוויה מאושרת לשימוש בבית החולים:

טיפול ב-pulmonary hypertension בילודים עד גיל חודש, המאושפדים בטיפול נמרץ ילדים ואינם סופגים אנטרלית.



סטאטוס רישום:

- התכשיר אינו רשום במדינת ישראל.
- השימוש בכפוף לטופס 29ג' מוסדי

טווח מינונים:

(NeoFax & UpToDate):

יילודים משבוע 32:

- מנת העמסה של 0.4mg/kg הניתנת במשך 3 שעות
- ולאחריה מנת אחזקה של 1.6mg/kg/day (0.067mg/kg/h).

קווים מנחים אירופאיים⁶:

- מנת העמסה אופציונאלית של 0.4mg/kg הניתנת במשך 3 שעות
- ולאחריה מנת אחזקה של 1.6-2.4mg/kg/day
- במקרים נדירים תואר מתן מינון גבוה יותר של עד 7.2mg/kg/day
- מינון מקסימאלי: 30mg/day

התאמות מינון בכשל כלייתי או כבדי:

- אין צורך להתאים מינון בכשל כלייתי
- אין צורך להתאים מינון בכשל כבדי קל עד בינוני (Child-Pugh class A and B)
- אין לתת בכשל כבדי חמור (Child-Pugh class C).

תופעות לוואי עיקריות:

- תת לחץ דם סיסטמי וצורך מוגבר בואזופרסורים.
- ירידה בחמצון.

אינטראקציות בין תרופתיות חשובות:

- אין לתת Sildenafil לחולים המקבלים organic nitrates כלשהם (התרופה היחידה הרלבנטית לאוכלוסיית טיפול נמרץ ילדים היא Nitroglycerin)
- ריכוזו של Sildenafil עלול לעלות משמעותית בשילוב עם מעכבי CYP3A4 (דוגמאות רלבנטיות לאוכלוסיית היעד של פרטוקול זה: Fluconazole, Isavuconazole, Voriconazole, Erythromycin, Clarithromycin, Amiodarone, Cyclosporin A). חלק מהשילובים אינם מומלצים וחלקם מחייבים ניטור ומעקב אחר החולה. יש לבדוק כל מקרה לגופו.
- ייתכן צורך במינון גבוה יותר של Sildenafil בחולים המטופלים באינדוסורים של CYP3A4 (דוגמאות רלבנטיות לאוכלוסיית היעד של פרטוקול זה: Bosentan, Rifampicin, Carbamazepine, Phenytoin, Phenobarbital, Primidone). השילוב מחייב ניטור ומעקב אחר החולה.

שם התכשיר המסחרי: Revatio 10mg/12.5 mL

שם	תפקיד	תאריך	
ד"ר מאיה לוצקי	רוקחת קלינית	ספטמבר 2023	נכתב ע"י
ד"ר מרואן חנא	רוקח קליני	מאי 2026	עודכן ע"י

אופן מתן I.V.Sildenafil בטיפול נמרץ
ילדים

עמוד 1 מתוך 2

תאריך אפקטיבי: 12.05.2026

אופן המתן:

ילודים ממשקל 1.2 ק"ג:

- אין לדלל את התכשיר לפני המתן. התכשיר המסחרי (0.8mg/mL) מוכן לשימוש.
- יש לשאוב מהאמפולה למזרק את המינון הדרוש ל-24 שעות ליילוד, כולל מנת ההעמסה, באם ניתנת.
- אין לשמור שאריות מהתמיסה בבקבוקון.
- יש לתת באמצעות משאבת מזרק.
- בילדים הזקוקים לקצב עירוי נמוך מ- 0.1ml/hr במשאבת המזרק, יש לדלל לריכוז 0.1-0.4 mg/ml ב Dextrose 5% in Water (D5W).
- המזרק יציב ל-24 שעות בטמפ' החדר או במקרר.

פגים וילודים במשקל > 1.2 ק"ג:

- יש לדלל את התמיסה המרוכזת לריכוז 0.1-0.4mg/mL ב-D5W.
- המזרק יציב ל-24 שעות בטמפ' החדר או במקרר.
- יש לתת באמצעות משאבת מזרק.

סימוכין:

1. NeoFax® Drug Monograph Summary – MICROMEDEX. Online database, Accessed 21.5.26

2. FDA – Prescribing Information, Revised 1/2023, URL:
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/203109s016,022473s176lbl.pdf

3. Stabilis 4.0, online database, accessed 21.5.26, URL:
<https://www.stabilis.org/Monographie.pdf.php?Molecule=Sildenafil%20citrate>

4. Australasian Neonatal Medicines Formulary (ANMF), Accessed 21.5.24, URL:
https://www.anmfonline.org/wpcontent/uploads/2023/05/Sildenafil_ANMFv2.0_20210729.pdf

5. South Australian Neonatal Medication Guidelines, Accessed 11.5.24, URL:
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/90024a0045dc4497a9a0e9574adac1f8/Sildenafil_Neo_v2_0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE_90024a0045dc4497a9a0e9574adac1f8-p4cgZoB

6. Kaestner M, et al. Heart 2016;102:ii57–ii66. doi:10.1136/heartjnl-2015-307774. Pulmonary hypertension in the intensive care unit. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK.

7. Hansmann et al. J Heart Lung Transplant 2019; 38:879-901.
<https://doi.org/10.1016/j.healun.2019.06.022> 2019 updated
consensus statement on the diagnosis and treatment of pediatric pulmonary hypertension: The European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN), endorsed by AEPC, ESPR and ISHLT.

8. Schroeder L. et al. Intravenous sildenafil for treatment of early pulmonary hypertension in preterm infants. Sci Rep 2023 May 24;13(1):8405.

שם	תפקיד	תאריך	
נכתב ע"י	ד"ר מאיה לוצקי	רוקחת קלינית	ספטמבר 2023
עודכן ע"י	ד"ר מרואן חנא	רוקח קליני	מאי 2026